

Zmęczenie *współczuciem*

Specyficzna forma wypalenia u terapeutów, lekarzy, pielęgniarek. Inne mechanizmy — inne interwencje.

CZAS: 15 min refleksji Wsparcie ciągłe (superwizja)

ŹRÓDŁO: Figley (1995); Pearlman & Saakvitne (1995); Klimecki i in. (2014, fMRI); Stamm (2010, *ProQOL*); Neff & Germer (2013)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — trzy **różne mechanizmy** wyczerpania pomagaczy: zmęczenie współczuciem (ang. *compassion fatigue*), wtórna traumatyzacja, klasyczne wypalenie. W sekcji 02 — kluczowe rozróżnienie **empatia emocjonalna vs współczucie** (badanie Klimecki i in., 2014, fMRI): jedno wypala, drugie chroni. W sekcji 03 — sygnały ostrzegawcze, w sekcji 04 — pięć strategii ochronnych. Dziennik tygodniowy z trzema podskalami *ProQOL*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Figley (1995, „*Compassion Fatigue*”): osoby zawodowo pomagające — terapeuci, lekarze, pielęgniarce, pracownicy socjalni, służby ratunkowe — są narażone na specyficzny zespół wyczerpania empatycznego. Pearlman i Saakvitne (1995): **wtórna traumatyzacja** (ang. *vicarious traumatization*) — ekspozycja na traumy klientów zmienia samego terapeutę. Bride i in. (2004): około 15% terapeutów traumy spełnia kryteria zespołu stresu pourazowego (PTSD). Klimecki, Leiberg, Ricard i Singer (2014, badanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI): **empatia emocjonalna** (współodczuwanie cierpienia) aktywuje sieci bólu i prowadzi do wyczerpania, natomiast **współczucie** (motywacja do pomocy bez przejmowania cierpienia) aktywuje sieci nagrody i **chroni** przed wypaleniem. Klucz dla pomagacza: trening przejścia od jednego do drugiego. Neff i Germer (2013): **samowspółczucie terapeutów** (ang. *self-compassion*) jest pojedynczo najsilniejszym predyktorem odporności na zmęczenie współczuciem. Superwizja i osobista terapia w zawodach pomagających nie są luksusem — są profesjonalną koniecznością.

01 📖 Trzy różne mechanizmy — różne interwencje

1 · ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM

empatyczne wyczerpanie

Stopniowe wyczerpanie zasobów empatii. Trudność współodczuwania, dystans, „znieczulenie”. Mechanizm: chroniczne współodczuwanie bez regeneracji. Interwencja: *granice empatii, rytuały zamknięcia, samowspółczucie*.

2 · WTÓRNA TRAUMATYZACJA

objawy podobne do PTSD

Intruzje (obrazy traumatycznych historii klientów), unikanie, hiperaktywacja, zmiana światopoglądu. Mechanizm: ekspozycja na opowieści traumatyczne. Interwencja: *superwizja traumy, EMDR jeśli wskazane, ograniczenie obciążenia*.

3 · KLASYCZNE WYPALENIE

model Maslach

Wyczerpanie + cynizm + obniżona skuteczność — wynik nierównowagi wymagań i zasobów (nie tylko ekspozycji na cierpienie). Interwencja: *standardowy plan recovery, granice, sen, ruch, sieć wsparcia*.

02 🧠 Empatia emocjonalna vs współczucie — klucz Klimecki

EMPATIA EMOCJONALNA

współodczuwanie cierpienia

„Czuję twój ból razem z tobą”. Aktywuje te same sieci mózgu co własny ból (Klimecki 2014, fMRI). Chroniczne — prowadzi do wyczerpania, znieczulenia,

WSPÓŁCZUCIE

motywacja do pomocy

„Widzę twój ból, jestem przy tobie, chcę pomóc”. Aktywuje sieci nagrody i więzi (Klimecki 2014). Chroni przed wypaleniem. Klucz: **obecność bez fuzji**.

03 ? Sygnały ostrzegawcze — czego szukać u siebie

SYGNAŁY EMOCJONALNE

Odcięcie od klientów, cynizm wobec ich problemów, trudność współodczuwania, drażliwość, poczucie bycia „pochłoniętym” historiami klientów po godzinach pracy.

SYGNAŁY INTRUZYJNE

Powracające obrazy z sesji w czasie wolnym, koszmary o klientach, „śnienie sesji”. To *wtórna traumatyzacja* — wymaga superwizji traumy, nie zwiększenia obciążenia.

SYGNAŁY BEHAWIORALNE

Unikanie trudnych przypadków, spóźnianie się na sesję, skracanie sesji, „zapominanie” o pacjentach, przekładanie wizyt, picie alkoholu po pracy więcej niż zwykle.

SYGNAŁY SOMATYCZNE

Napięcie w karku i barkach po sesjach, bóle głowy, problemy z trawieniem, zaburzenia snu, „ciężar” w klatce piersiowej, częste przeziębienia (obniżenie odporności).

04 💡 Pięć strategii ochronnych dla pomagacza

1 • Superwizja regularnie. Nie tylko po kryzysie. Przestrzeń do przepracowania trudnych przypadków zanim staną się intruzjami.

2 • Limit trudnych przypadków. Maksymalnie 2–3 traumatyczne sesje dziennie, z buforem 30 min między nimi.

3 • Rytuał zakończenia dnia. Symboliczny gest (umycie rąk, krótki spacer, zmiana ubrania), który zamyka tryb „terapeuta”.

4 • Samowspółczucie. Mów do siebie tak, jak mówisz do klientów. Neff i Germer (2013): silnie chroni przed wypaleniem.

5 • Życie poza zawodem. Hobby, relacje, ruch, natura, czas bez kontekstu zawodowego. Bez tego nie ma z czego czerpać.

Klucz: nie można nalewać z pustego dzbanka. Zadbanie o siebie w zawodach pomagających nie jest egoizmem — jest *warunkiem profesjonalizmu*. Klient zasługuje na obecnego, regulującego się terapeutę, nie na heroicznie wypalonego. Stamm (2010, kwestionariusz *ProQOL*) wprowadziła pojęcie **satysfakcji ze współczucia** (ang. *compassion satisfaction*): doświadczenie sensu i nagrody z pomagania jest też wymiarem do monitorowania — jego spadek poprzedza zwykle zmęczenie współczuciem.